

 	Hôpital Bicêtre	Procédure
	DUODÉNO-PANCRÉATECTOMIE CÉPHALIQUE DPC	Réf : smq-reference
		Version : 1
		Date d'application : smq-dateapplication
		Date de fin de validité : smq-limval
		Page 1 sur 7

	NOM, FONCTION	DATE
RÉDACTION	Bouix Jean IBODE	21/01/2026
VALIDATION		Date de validation
APPROBATION	SMQ-APPROBATEURS	Date d'approbation

Groupe de travail : fiche opératoire chirurgie viscérale

Principales modifications par rapport à la version précédente : smq-objet-modif

1. OBJET

Cette fiche décrit la procédure et le matériel nécessaire lors d'une duodéno-pancréatectomie céphalique.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure s'applique au bloc opératoire commun du CHU de Bicêtre.

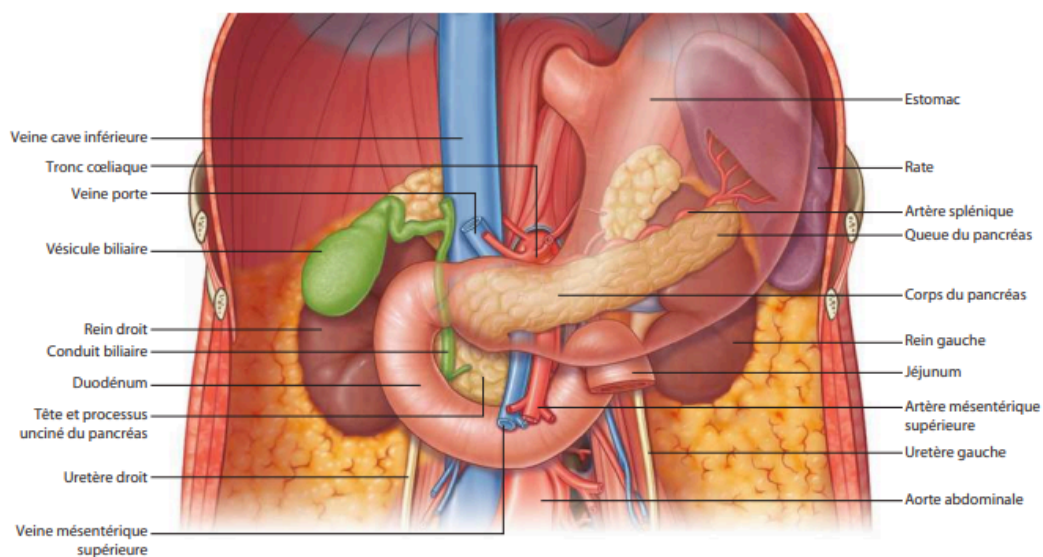
3. RESPONSABILITÉS/ PERSONNES CONCERNÉES

IBODE, IDE, EIBODE, chirurgiens, internes en chirurgie, externes.

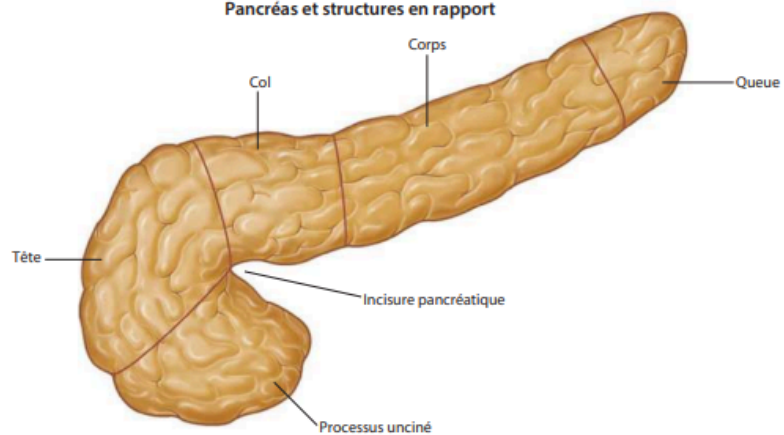
4. DESCRIPTION

Définition :

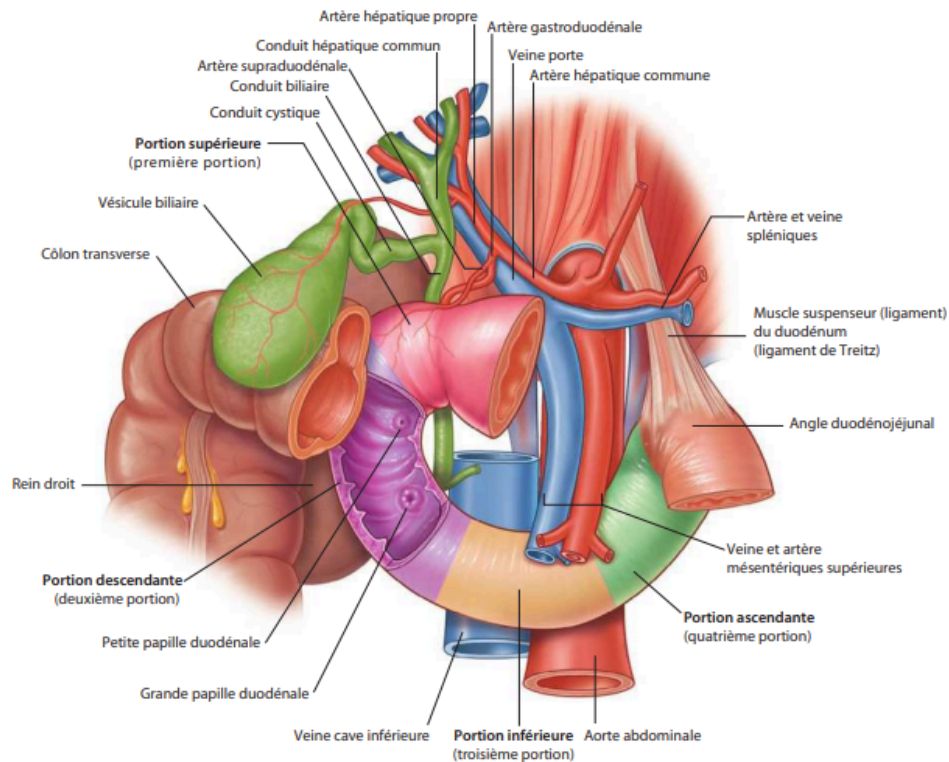
Intervention chirurgicale majeure consistant en la résection en bloc de la tête du pancréas, du duodénum, de la voie biliaire distale, de la vésicule biliaire et parfois de l'antre gastrique, suivie d'une reconstruction digestive complexe.



Pancréas et structures en rapport



Face antérieure du pancréas



Portions du duodénum et structures en rapport

Indications :

Oncologiques

Adénocarcinome de la tête du pancréas
Ampullome vaterien
Cholangiocarcinome distal
Tumeurs duodénales péri-ampullaires
Tumeurs neuroendocrines céphaliques

Non oncologiques (rares)

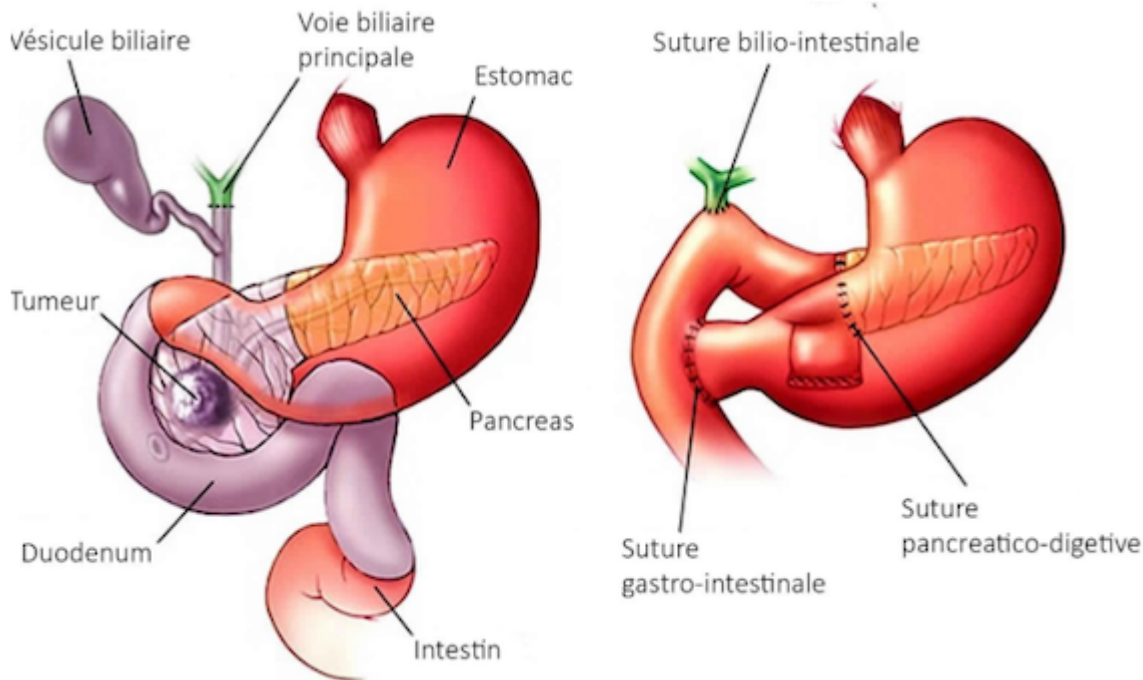
Pancréatite chronique compliquée
Traumatisme pancréatico-duodénal sélectionné

Contre-indications

Métastases hépatiques ou péritonéales
Envahissement artériel non résécable (AMS, tronc cœliaque)
Terrain non opérable

But :

Résection R0
Traitement curatif ou de contrôle tumoral
Soulagement de l'ictère / complications locales



Principe chirurgical

Laparotomie médiane
Temps de résécabilité capital
Résection monobloc
Reconstruction par 3 anastomoses principales

Temps opératoires

Exploration et résécabilité

Exploration hépatique et péritonéale
Manœuvre de Kocher
Évaluation veine porte / VMS / AMS
Si doute → biopsies extemporanées

Temps de résection Temps septique

Section du cholédoque distal
Cholécystectomie
Section gastrique (Whipple classique) ou préservation pylorique
Section du col pancréatique (au-dessus de la VMS)
Résection du duodénum
Curage ganglionnaire régional
Dégagement veine porte – VMS
Temps clé : plan rétro-pancréatique (AMS)

Temps de reconstruction **Temps septique**

Ordre classique :

Pancréatico-jéjunostomie

Anastomose la plus à risque

Pancréas mou = haut risque de fistule

Hépatico-jéjunostomie

Anastomose bilio-digestive

Sur anse montée

Gastro-jéjunostomie

Ou duodéno-jéjunostomie (préservation pylorique)

Drainage et fermeture **Temps Aseptique**

Drains au contact de la PJ $\pm$ HJ

Hémostase rigoureuse

Fermeture pariétale

Particularités techniques

Toujours résécabilité AVANT de réséquer

Pancréas mou + Wirsung fin = haut risque

Gestion vasculaire parfois nécessaire (porte/VMS)

Courbe d'apprentissage importante

Complications

<i>Précoces</i>	<i>Tardives</i>
Fistule pancréatique (la plus redoutée)	Insuffisance pancréatique exocrine
Retard de vidange gastrique	Diabète
Hémorragie post-op	Dénutrition
Abscès intra-abdominal	
Sepsis	

Surveillance post-opératoire

Surveillance en soins continus / réanimation

Diurèse, hémodynamique

Drain : débit, amylase

Biologie : Hb, CRP, bilan hépatique

Glycémies

Suites opératoires

Reprise alimentaire progressive

Enzymes pancréatiques si besoin

Ablation des drains selon évolution

Durée d'hospitalisation : 10–20 jours

Discussion RCP oncologique (chimiothérapie adjuvante)

Résultats / Pronostic

Dépend du stade tumoral

Morbidité élevée mais mortalité < 5 % en centres experts

Amélioration de la survie si R0

Installation

Décubitus dorsal bras le long du corp mise en place des 2 piquets

Matériel :

Mobile : 2 grandes tables 1 petite table 1 table mayo

Installation : Table opératoire, jambières, piquets, gélouses

DMRS

Boite laparotomie	Boite vasculaire gayral +/-
Ecarteur d'olivier	Ecarteur papin petit +/-
Pince bipolaire +/-	Ciseaux bipolaire M ou L
	Pince HEM-O-Lock

Consommables : DM et DMS

Pack universel	Champ abdominaux	Electrode neutre	Seringue Gavage 60 cc
Casaques	Poignée de scialytique	Compressees RX	Lame 23 et lame 11
Plateau badigeon	Tubulure aspiration	Cupules S et M	Pince à clip métallique automatique M
Electrode active	Canule aspi grosse	Pince à clip métallique automatique S	Clips HEM-O-Lock
Grattoire	Canule aspi petite	Boite à aiguilles	
Sonde urinaire thermique			

Fils de base :

Bobine 3-0 et 2-0 Vicryl 3-0 Prolene 4-0 et 5-0 aig 17 Prolene 3-0 aig 22	
--	--

Pharmacie :

Bétadine Rouge
Bétadine Jaune

Sérum physiologique

Examen :

Anatomo-pathologie avec extempo